ITAPEMA
Medicina Laboratorial

==========

Pedido.....: **008-451402** Data:**12/01/2026**
Nome.....: **DAVI DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA**
RG.....: **62344835-x** DN:**30/04/2007** Idade: **18A**
Convênio...: **Sus - Gja**
Solicitante: **CAROLINA ZAVATINI PEREIRA**
Cadastro...: **12/01/26 08:50** Emissão.:**20/01/26 11:07**

==========

Exames Solicitados:

A1C AU B12 BTF CA CRT FAL FTA GL GT HBE HC HIV HMP K LIPC MG MONO MONO NA PPF T1 T4 TGO TGP TSH UR VD VD25

Os exames laboratoriais sofrem interferências fisiológicas, patológicas e medicamentosas, portanto,somente o médico poderá interpretá-los.

Gestão de qualidade certificado ISO 9001:2015 e ótimo desempenho em ensaios laboratoriais pela Sociedade Brasileira de Medicina Laboratorial (SBPC).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- Dr. Bruno Sanchez de Moraes - Médico Pat. Clínico CRM 130505

Itapema Laboratório de Análises Clínicas Ltda.

Rua Montenegro, 152 - Guarujá - (13) 21049999
Rua Montenegro, 168 - Guarujá
Rua 24 de Agosto, 205 - Vic. de Carvalho - (13) 33521548
www.italab.com.br

0080451402

LIB:13/01/2026 13:40
Luciana Hermida
CRBM: 7118

HEMOGRAMA COMPLETO

ERITRÓCITOS: **4.87 milh./mm3** HEMATOCRITO: **44.7%** HEMOGLOBINA: **15.4 g/dL**
Homem : 4.5 - 5.5 milh./mm3 Homem : 40 - 50% Homem : 13 - 16 g/dL
Mulher: 4.0 - 5.0 milh./mm3 Mulher: 37 - 45% Mulher: 12 - 15 g/dL

CONSTANTES HEMATOLÓGICAS

H.C.M: 31.6 uug	C.H.C.M: 34.5%	V.C.M: 91.8 u3	RDW: 12.2%
N: 27 - 31 uug	N: 32 - 36%	N: 80 - 98 u3	N: 11.5 - 14.5%

Contagem Global
LEUCÓCITOS: **4900** /mm3 Normal: 4000 - 10000/mm3

Contagem diferencial:

Celulas	Valor rel.	Normal	Valor abs	Normal
Neutrófilos metamielócitos:	0.0	0- 1	0	0- 100
Neutrófilos bastonetes :	0.0	0- 5	0	0- 500
Neutrófilos segmentados :	51.2	55-70	2509	2200-7000
Eosinófilos :	3.1	2- 4	152	80- 400
Basófilos :	0.7	0- 1	34	0- 100
Linfócitos típicos :	28.8	15-30	1411	600-3000
Linfócitos atípicos :	0.0	-----	0	---------
Monócitos :	16.2	4- 8	794	160- 800

CONTAGEM DE PLAQUETAS:

Resultado: **167.000** /mm3
V. de referência: 150.000 a 450.000/mm3

Método: óptica por fluorescência (laser).

LIB:12/01/2026 17:09
Vera Henriques
CRBM: 9166

GLICEMIA

Resultado: **85 mg/dL**
V. de referência:

Menor que 100 mg/dL	- Normal
100 - 125 mg/dL	- Pré-diabetes
Maior ou igual a 126 mg/dL	- Diabetes Mellitus

- Gestantes:

Menor que 92 mg/dL	- Normal
92 - 125 mg/dl	- Diabetes Mellitus Gestacional
Maior ou igual a 126 mg/dL	- Diabetes Mellitus

Nota: Para a confirmação do Diabetes Mellitus Tipo 2, além da glicemia em jejum é necessário que a glicemia 2 horas após sobrecarga de 75g de glicose ou a hemoglobina glicada também estejam alterados. Se somente um exame estiver alterado, este deverá ser repetido para a confirmação.

Método: IR enzimático (N-Sulfopropil) oxidase.

Fonte: Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes.

LIB:13/01/2026 08:16
Vera Henriques
CRBM: 9166

LIPIDOGRAMA COMPLETO (SANGUE)

Colesterol Total :	**107 mg/dL**	Colesterol LDL :	**62 mg/dL**
Colesterol HDL :	**29 mg/dL**	Colesterol Não HDL:	**78 mg/dl**
Triglicérides :	**75 mg/dL**	Colesterol VLDL :	**16 mg/dL**

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS DO PERFIL LIPÍDICO DE ACORDO COM A IDADE

IDADE	**0 A 9 ANOS**	**10 A 19 ANOS**	**MAIOR DE 20 ANOS**
COLESTEROL TOTAL	< 170 mg/dL	< 170 mg/dL	< 190 mg/dL
COLESTEROL HDL	> 45 mg/dL	> 45 mg/dL	> 40 mg/dL
TRIG. COM JEJUM	< 75 mg/dL	< 90 mg/dL	< 150 mg/dL
TRIG. SEM JEJUM	< 85 mg/dL	< 100 mg/dL	< 175 mg/dL
COLESTEROL LDL	< 110 mg/dL	< 110 mg/dL	**VER ABAIXO**

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA A CATEGORIA DE RISCO CARDIVASCULAR ESTIMADA PELO MEDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS.

RISCO CARD.	**ALVO P/ COLESTEROL LDL**	**ALVO P/ COLESTEROL NÃO HDL**
BAIXO	< 130 mg/dL	< 160 mg/dL
INTERMEDIÁRIO	< 100 mg/dL	< 130 mg/dL
ALTO	< 70 mg/dL	< 100 mg/dL
MUITO ALTO	< 50 mg/dL	< 80 mg/dL

- Segundo o novo Consenso Brasileiro, existe agora a necessidade prévia de classificar cada paciente para a categoria de risco cardiovascular (baixo, intermediário, alto ou muito alto) e após isto, verificar o alvo terapêutico que cada um deve manter(**www.italab.com.br/calculadora**).
- Pacientes com diabetes e sem fatores de risco ou sem evidência de aterosclerose subclínica devem manter o LDL-C abaixo de 100mg/dL. Pacientes com fatores de risco ou doença aterosclerótica subclínica devem manter o LDL-C abaixo de 70mg/dL. Pacientes com história de infarto agudo do miocárdio, AVC ou vascularização coronariana, carotídea ou periférica, ou história de amputação devem manter o LDL-C abaixo de 50mg/dL.
- Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440mg/dL(sem jejum) sugere-se nova determinação do triglicérides com jejum de 12 horas.
- Valor de Colesterol Total maior ou igual 310 mg/dL (adultos) ou maior ou igual 230mg/dL (2 a 19 anos) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar.
- Fonte: Consenso Bras. p/ Normatização da Det. Lab. do Perfil Lipídico. Método: Enzimático

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

URÉIA - BUN (SANGUE)

Resultado: **11.0** mg/dL
V. de referência: 5.0 a 23.0 mg/dL
Método: UV (Urease/Glutamato dehidrogenase)

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

CREATININA (SANGUE)

Resultado : **0.9** mg/dL

V. de referência :
Mulheres: 0.5 a 0.9 mg/dL
Homens : 0.7 a 1.2 mg/dL

Método : Cinético (Jaffé mod.).

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

SÓDIO (SANGUE)

Resultado: **136** mEq/L.
V. de referência: 134 a 146 mEq/L
Método: Íon seletivo

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

POTÁSSIO (SANGUE)

Resultado: **4.1** mEq/L
V. de referência: 3.5 a 5.0 mEq/L
Método: Íon seletivo.

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO)

Resultado: **32** U/L
V. de referência: 7 a 52 U/L
Método: UV otimizado.

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP)

Resultado: **81** u/L
V. de referência: 7 a 48 U/L
Método: UV otimizado.

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

BILIRRUBINAS (SANGUE)

Bilirrubinas diretas : **0.2** mg/dL
Bilirrubinas indiretas: **0.5** mg/dL
Bilirrubinas totais : **0.7** mg/dL

V. de referência: Bilirrubina direta : até 0.3 mg/dL
Bilirrubina indireta : até 1.2 mg/dL
Bilirrubinas totais : até 1.4 mg/dL
Método: Diazo modificado.

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

GAMAGLUTAMILTRANSFERASE-(G GT)

Resultado: **73** U/L
V. de referência: Homens : 12 a 64 U/L
Mulheres: 09 a 36 U/L
Método: Enzimático

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

FOSFATASE ALCALINA (SANGUE)

Resultado : **169** U/I

V. de referência: Adultos (20 A 60 anos) : 65 a 300 U/I
Crianças e adolescentes: até 645 U/I

Método : Cinético otimizado (DGKC y SSCC)

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

CÁLCIO (SANGUE)

Resultado: **9.0** mg/dL
V. de referência: 8.5 A 10.5 mg/dL
Método: Arsenazo III.

LIB:12/01/2026 17:09 Vera Henriques CRBM: 9166

MAGNÉSIO (SANGUE)

Resultado: **2.0** mg/dL
V. de referência: 1.5 a 2.5 mg/dL
Método: Azul Xilidil.

LIB:14/01/2026 13:06
Bianca Silva
CRBM: 28052

FLOCULAÇÃO (V.D.R.L.), REAÇÃO DE

Resultado: **Negativo**

V. de referência: Negativo

Método: Floculação (não treponêmico)

Nota:
- Este laboratório utiliza o fluxograma 1 , na qual se emprega um teste não treponêmico como primeiro teste, seguido por um teste treponêmico (teste rápido IgM e IgG) para a complementação da testagem.
- Análises realizadas por diferentes fluxos, metodologias ou marcas de testes possuem comparatibilidade prejudicada, devendo o médico avaliar com cautela.
- Em casos discordantes, deve-se submeter a amostra a um terceiro teste treponêmico de metodologia diferente do teste anteriormente realizado.
- Em aproximadamente 85% dos casos, os testes treponêmicos permanecem reagentes durante toda a vida nas pessoas que contraem a sífilis, independentemente de tratamento.
- Estima-se que em 0,2% a 0,8% dos casos com resultados reagentes para os testes não treponêmicos podem estar associados a outras condições clínicas, transitórias ou permanentes.
- Importante associar o resultado da testagem à informações clínico-epidemiológicas para avaliar a ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.
- Persistindo a dúvida, nova amostra deverá ser coleta após 30 dias.

Fonte: Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis 2021- Ministério da Saúde.

LIB:14/01/2026 13:06
Bianca Silva
CRBM: 28052

TESTE TREPONÊMICO P/ SÍFILIS ANTICORPOS TOTAIS (IgG E IgM)

Resultado: **Negativo**
V. de referência: Negativo.
Método: Imunoensaio cromatográfico

Nota:

- Análises realizadas por diferentes fluxos, metodologias ou marcas de testes possuem comparatibilidade prejudicada, devendo o médico avaliar com cautela.
- Em casos discordantes entre os testes treponêmicos e não treponêmicos, deve-se submeter a amostra a um terceiro teste treponêmico de metodologia diferente do teste anteriormente realizado.
- Em aproximadamente 85% dos casos, os testes treponêmicos permanecem reagentes durante toda a vida nas pessoas que contraem a sífilis, independentemente de tratamento.
- Importante associar o resultado da testagem à informações clínico-epidemiológicas para avaliar a ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.
- Persistindo a dúvida, nova amostra deverá ser coleta após 30 dias.

Fonte: Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis 2021- Ministério da Saúde.

LIB:13/01/2026 18:03
LAB. ITAPEMA

EXAME DE URINA DE ROTINA

1 - EXAME FÍSICO

DENSIDADE(REFRACTOMETRO).: **1.025** Normal: 1.001 a 1.030
pH.....: **Ácido** Normal: Ácido

2 - EXAME QUÍMICO

PROTEÍNAS	GLICOSE	CORPOS CETÔNICOS
Normal	**Normal**	**Negativo**
N: Até 70 mg/L	N: Até 50 mg/dL	N: Negativo

SAIS BIL./BILIRRUBINAS	UROBILINOGÊNIO	HEMOGLOBINA
Negativo	**Normal**	**Negativo**
N: Negativo	N: < 1 mg/dL	N: Negativa

ESTERASE LEUCOCITÁRIA		NITRITO
Negativo		**Negativo**
N: Negativo		N: Negativo

3 - EXAME MICROSCÓPICO

CEL. EPITELIAIS	LEUCÓCITOS	HEMÁCIAS
< 10.000 /mL	**< 10.000** /mL	**< 5.000** /mL
N: 0-10.000/mL	N: 0-10.000/mL	N: 0-5.000/mL

CILINDROS: **Ausentes**
CRISTAIS: **Ausentes**
MUCO: **(++)**
PARASITAS: **Ausentes**

Método: Analisador automático e microscopia.



LIB:19/01/2026 09:58
Karime Balarini
CRBM: 12153

PARASITOLÓGICO - AMOSTRA ÚNICA

Resultado: Negativo

Valor de referência: Negativo

Método..: HOFFMAN MODIFICADO

Nota: Considerar resultados Negativos como a não visualização de ovos ou larvas de helmintos, cistos e trofozoítos de protozoários na amostra.

LIB:14/01/2026 13:17
Karime Balarini
CRBM: 12153

SANGUE OCULTO ANTICORPOS MONOCLONAIS

Resultado: **Negativo**
V. de referência: Negativo
Método: Imunoensaio qualitativo

Obs. A amostra não deve ser coletada durante ou no prazo de três dias de um período menstrual, ou se o paciente sofre de hemorragias, hemorróidas ou sangue na urina. Álcool, aspirina e outros medicamentos tomados em excesso podem causar irritação gastrointestinal resultando no sangramento oculto. Essas substâncias devem ser interrompidas pelo menos 48 horas antes do teste. Restrições dietéticas não são necessárias.

LIB:19/01/2026 14:31
Karime Balarini
CRBM: 12153

SANGUE OCULTO ANTICORPOS MONOCLONAIS

Resultado: **Negativo**
V. de referência: Negativo
Método: Imunoensaio qualitativo

Obs. A amostra não deve ser coletada durante ou no prazo de três dias de um período menstrual, ou se o paciente sofre de hemorragias, hemorróidas ou sangue na urina. Álcool, aspirina e outros medicamentos tomados em excesso podem causar irritação gastrointestinal resultando no sangramento oculto. Essas substâncias devem ser interrompidas pelo menos 48 horas antes do teste. Restrições dietéticas não são necessárias.



LIB:13/01/2026 16:26
Nathali Nogueira
CRBM 55498

HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) - ULTRASENSÍVEL

Resultado: **0.77** µUI/mL

Referência:
Prematuros (28 a 36 semanas): 0,70 a 27,00 µUI/mL
Recém nascidos (1 a 4 dias): 1,00 a 39,00 µUI/mL
2 a 20 semanas.....: 1,70 a 9,10 µUI/mL
5 meses a 20 anos.....: 0,70 a 6,40 µUI/mL

Adultos: 0,38 a 5,33 µUI/mL

Gravidez:
1° trimestre: 0,05 a 3,70 µUI/mL
2° trimestre: 0,31 a 4,35 µUI/mL
3º trimestre: 0,41 a 5,18 µUI/mL

Método: Quimioluminescência

LIB:13/01/2026 16:26
Nathali Nogueira
CRBM 55498

T4 TOTAL

Resultado: **10.10** µg/dL

V. de referência:

Cordão.....: 7,4 a 13,0 µg/dL
1 a 3 dias...: 11,8 a 22,6 µg/dL
1 a 2 semanas: 9,8 a 16,6 µg/dL
1 a 4 meses..: 7,2 a 14,4 µg/dL
4 a 12 meses.: 7,8 a 16,5 µg/dL
1 a 5 anos...: 7,3 a 15,0 µg/dL
5 a 10 anos..: 6,4 a 13,3 µg/dL
10 a 12 anos.: 5,6 a 11,7 µg/dL

Homens e Mulheres acima de 12 anos: 5,1 a 14,1 µg/dL

Soro materno: 9,1 a 14,0 µg/dL

MÉTODO:QUIMIOLUMINESCÊNCIA

LIB:13/01/2026 15:30
Nathali Nogueira
CRBM 55498

HCV, ANTI

Resultado: **0.11**

V. de referência:

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):
O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV.
Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):
Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES:
1)A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao.
4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-de-a-a-z/c/ calendario-nacional-de-vacinacao.

MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA



LIB:13/01/2026 16:26
Nathali Nogueira
CRBM 55498

VITAMINA B12

Resultado: **220** pg/mL

Referência:
Feminino.: 114 a 890 pg/mL
Masculino: 130 a 868 pg/mL

MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

LIB:13/01/2026 15:30
Nathali Nogueira
CRBM 55498

25 - HIDROXIVITAMINA D

Resultado: **20.1** ng/mL

V. de referência:

Deficiência.....: Inferior a 20,0 ng/mL
Valores normais para a população geral.: Entre 20,0 e 60,0 ng/mL
Valores ideais para população de risco*: Entre 30,0 e 60,0 ng/mL
Risco de intoxicação.....: Superior a 100,0 ng/mL

* Entende-se por população de risco: idosos (acima de 65 anos), gestantes , indivíduos com fraturas e quedas frequentes, pós-cirurgia bariátrica, em uso de fármacos que interferem no metabolismo da vitamina D, doenças osteometabólicas (osteoporose, osteomalácia, osteogênese imperfeita, hiperparatireoidismo primário e secundário), sarcopenia, diabetes mellitus tipo 1, doença renal crônica, insuficiência hepática, anorexia nervosa, síndrome de má absorção e câncer.

Método: Quimioluminescência.

LIB:14/01/2026 09:13
Vera Henriques
CRBM: 9166

HBe-AG - HEPATITE B

Resultado: **0.37**

V. de referência:

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

MÉTODO:QUIMIOLUMINESCÊNCIA

LIB:13/01/2026 15:30
Nathali Nogueira
CRBM 55498

HBS-AG (HEPATITE B)

RESULTADO: **0.43**

Valor Referência: Não Reagente : Inferior a 0,90
Indeterminado : Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00
Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Conforme disposto na RDC nº978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg):
O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg):
Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES:
1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/ saude-de-a-a-z /c /calendario-nacional-de-vacinacao 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao.

MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA



LIB:14/01/2026 13:31
Bianca Silva
CRBM: 28052

HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - CLIA

Resultado: **Amostra não reagente para HIV**
Leitura : **0.35**

V. de Referência:
Não reagente....: Inferior a 1,00
Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HIV:

- O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus HIV. Há de se considerar o período da Janela Imunológica.
- Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da amostra atual.

AMOSTRA REAGENTE PARA HIV:

- Somente será considerado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HIV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório como Western Blot, Imuno Blot ou Teste Molecular (PCR).

OBSERVAÇÕES:
1 - A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para detecção da infecção pelo HIV não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
2 - Resultados falso-positivos em testes de triagem (por imunoensaio) para HIV podem ocorrer em pacientes com doenças autoimunes, hepatopatias, dialisados e em terapia com interferon, após vacinação recente contra influenza A-H1N1, múltiplas transfusões de sangue e gravidez.
3 - Resultados falso-negativos em testes de triagem (por imunoensaio) para HIV podem ocorrer na infecção aguda pelo HIV, em indivíduos imunossilenciosos, indivíduos com sistema imunológico comprometido e quando o teste for realizado anteriormente à soroconversão.
4 - A passagem transplacentária de anticorpos maternos do tipo IgG anti-HIV, principalmente no terceiro trimestre de gestação, interfere no diagnóstico sorológico da infecção vertical. Os anticorpos maternos podem persistir até os 18 meses de idade. Portanto, métodos que realizam a detecção de anticorpos não são recomendados para o diagnóstico em crianças menores de 18 meses de idade, sendo necessária a realização de testes moleculares, como a quantificação do RNA viral).

0080451402

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA.

CONTINUAÇÃO HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - CLIA

5 - A interpretação de qualquer resultado laboratorial para pesquisa de infecção pelo HIV requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA - IMUNOENSAIO DE 4ª GERAÇÃO

LIB:13/01/2026 11:35
Nathali Nogueira
CRBM 55498

HEMOGLOBINA GLICADA - A1c

Resultado: **4.9** %
Glicemia estimada média: **94** mg/dL

V. de referência:
Hb A1c Normal: Menor que 5,7%
Pré-diabetes.: 5,7% a 6,4%
Diabetes.....: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:
Pacientes DM1 ou DM2.: menor que 7,0%
Idoso Saudável.....: menor que 7,5%
Idoso Comprometido...: menor que 8,5%
Criança e Adolescente: menor que 7,0%

A Diretriz SBD recomenda utilizar, como critérios de diagnóstico de DM, a glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL, a HbA1c maior ou igual a 6,5%, a glicemia no TTGO- 1h maior ou igual a 209 mg/dL ou a glicemia no TTGO- 2h maior ou igual a 200 mg/dL. Se somente um exame estiver alterado, este deverá ser repetido para confirmação. Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente. A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C. O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2025)

MÉTODO: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC

.

ISABELA BAREISYS DE SOUSA
CRBM 33.632
ASSINATURA DIGITAL: MSOMLYFCOJGNZRGMN/260120110759

0080451402